Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Infectologia

Antibioticoterapia

Escolhas empíricas e doses nas infecções comuns

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Antibioticoterapia empírica em pediatria · escolhas e doses nas infecções comuns

I Antes de prescrever 3
Dose por dia × por tomada, componente, alergia verdadeira

II Sepse e choque: quando e com o quê? 4

III Meningite após os 2 meses 5
Esquema empírico, por agente, pneumococo resistente

IV Meningite antes dos 2 meses 6

V Quimioprofilaxia de contatos 7
Meningococo e Haemophilus b (NT 154/2024)

VI Infecção urinária: diagnóstico 8
Coleta, sedimento e cortes de urocultura

VII Infecção urinária: tratamento e depois 9

VIII Vias aéreas em uma página 10
OMA, faringite, sinusite, pneumonia

IX Pele e disenteria 11

X Recém-nascido e lactente pequeno 12

XI Mapa de decisão e pegadinhas 13

XII Questões de estudo 14

— Gabarito, fontes e anotações 15

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

Quando a dose aparece sem teto, a fonte daquela indicação não o informa; não completar por memória. Lista de chaves de fonte no fim.

Capítulo I

Antes de prescrever

Uma prescrição de antibiótico completa diz: diagnóstico, se precisa mesmo de antibiótico, culturas, fármaco, dose, intervalo, formulação, via, ***duração com data de término*** *e quando reavaliar [AWaRe].*

Tabela 1 · *Erros de cálculo que mais acontecem*

Armadilha	Como evitar
mg/kg/dia* × *mg/kg/dose	Amoxicilina da PAC ambulatorial é 50 mg/kg/**dia**; ampicilina da PAC internada é 50 mg/kg/**dose** de 6/6 h. Manter a unidade da fonte [SBP-PAC]
Amoxicilina-clavulanato	Calcular pela **amoxicilina** [AWaRe]
Sulfametoxazol-trimetoprima	Calcular pela **trimetoprima** [AWaRe] [SBP-ITU]
Volume	Conferir a concentração da suspensão antes de converter mg em mL [AIDPI]
Função renal	As tabelas pediátricas do AWaRe supõem rim e fígado normais [AWaRe]

"Alérgico a penicilina"

Tabela 2 · *Classificar antes de trocar*

Náusea, vômito, diarreia isolados; história familiar	Não é alergia; rever o rótulo
Exantema leve, sem acometimento sistêmico	Não exclui automaticamente todos os betalactâmicos
Urticária, angioedema, broncoespasmo, anafilaxia	Reação imediata: escolher a alternativa com cuidado
Bolhas, mucosas, lesão de órgão	Reação tardia grave: não reexpor sem especialista

[AWaRe]. Cefalosporinas servem em muitas alergias não graves; após reação com risco de vida, evitar betalactâmicos ou consultar especialista.

Atenção · nada de dose-teste improvisada

Provocação oral é avaliação supervisionada, com capacidade de tratar reação aguda; teste cutâneo de rotina antes de toda penicilina não é recomendado [AWaRe].

Capítulo II

Sepse e choque: quando e com o quê?

*O relógio manda: **choque suspeito**, antimicrobiano imediatamente, idealmente **em até 1 hora**; **sepse provável sem choque**, avaliação rápida e início idealmente **em até 3 horas** [SSC].*

- Hemocultura antes do antibiótico, se não atrasar a dose; lactato na avaliação inicial [SSC].
- O escore Phoenix define sepse (≥ 2 pontos) e choque séptico (≥ 1 ponto cardiovascular), mas **não se espera o escore para tratar** [PHX] [SSC].
- Sinais gerais de perigo (não bebe, vomita tudo, letargia, convulsão) pedem referência urgente [AIDPI].

Tabela 3 · *Sepse comunitária fora do período neonatal (AWaRe)*

Primeira escolha	Ampicilina **50 mg/kg/dose IV 8/8 h** (máx. 6 g/dia) + gentamicina **7,5 mg/kg/dose IV 1×/dia**
Alternativas	Ceftriaxona **80 mg/kg/dose IV 1×/dia** (máx. 3 g/dia) ou cefotaxima **50 mg/kg/dose IV 8/8 h**
Duração	Cerca de 7 dias, conforme o foco

[AWaRe]. No Brasil, a escolha final segue o foco provável, a resistência local e o protocolo do serviço.

Conduta · depois das primeiras doses

- Com agente e antibiograma: **estreitar**.
- Sem agente: estreitar ou suspender conforme foco, evolução e avaliação; procalcitonina não é rotina para descalonar onde já há gestão de antimicrobianos [SSC].

Cai na prova · o choque do capítulo de choque

Fluidos, vasoativos e metas da primeira hora estão no caderno de Choque. Aqui, só o antibiótico: **não atrasar** por exame [SSC].

Capítulo III

Meningite após os 2 meses

Empírico: ***cefalosporina de 3ª geração****, ceftriaxona ou cefotaxima. Ampicilina + cloranfenicol só se elas faltarem; cloranfenicol é a opção inicial na anafilaxia a betalactâmicos [MS-GVS].*

Tabela 4 · *Meningite bacteriana > 2 meses, por agente (doses diárias IV)*

Agente	Antibiótico	Duração
Empírico	Ceftriaxona **100 mg/kg/dia 12/12 h** ou cefotaxima **200 mg/kg/dia 6/6 h**	—
Meningococo	Penicilina 200–400 mil UI/kg/dia 4/4 h · ampicilina 200–300 mg/kg/dia 6/6 h · ceftriaxona 100 mg/kg/dia 12/12 h	5–7 dias
Pneumococo sensível	Penicilina G 200–400 mil UI/kg/dia 4/4 h ou ampicilina 200–300 mg/kg/dia 6/6 h	10–14 dias
Pneumococo resistente à penicilina, sensível à cefalosporina	Ceftriaxona ou cefotaxima, nas doses acima	10–14 dias
Pneumococo resistente às duas	**Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6 h + cefalosporina de 3ª geração** (+ rifampicina 20 mg/kg/dia 12/12 h, ver abaixo)	10–14 dias
H. influenzae	Ceftriaxona ou cefotaxima	7–10 dias
Bacilos Gram-negativos	Ceftriaxona ou cefotaxima	21 dias
Pseudomonas	Ceftazidima 150–200 mg/kg/dia 8/8 h	21 dias

[MS-GVS]. O Guia não informa doses máximas pediátricas; a linha de Listeria está incompleta no texto e não foi usada.

Atenção · quando acrescentar rifampicina

No pneumococo resistente às cefalosporinas: piora após **24–48 h** de vancomicina + cefalosporina, líquor que não esteriliza ou CIM ≥ 4 μg/mL para ceftriaxona/cefotaxima. **Vancomicina nunca sozinha**: penetra mal no líquor [MS-GVS].

Cai na prova · o exame não atrasa o antibiótico

Colher sangue e líquor quando possível, mas punção lombar e tomografia **não atrasam** o tratamento [MS-NT] [AWaRe]. A ceftriaxona do Ministério é **de 12/12 h** na meningite.

Capítulo IV

Meningite antes dos 2 meses

Empírico: ***ampicilina + cefotaxima****; alternativa, ampicilina + aminoglicosídeo (gentamicina ou amicacina).* ***Evitar ceftriaxona no período neonatal****: compete com a bilirrubina [MS-GVS].*

Tabela 5 · *Doses diárias IV no lactente < 2 meses com meningite*

Fármaco	≤ 7 dias, < 2.000 g	≤ 7 dias, > 2.000 g	> 7 dias, < 2.000 g	> 7 dias, > 2.000 g
Ampicilina	100 mg/kg/dia 12/12 h	150 mg/kg/dia 8/8 h	150–200 mg/kg/dia 8/8 h	200–300 mg/kg/dia 6/6 h
Penicilina cristalina	100 mil UI/kg/dia 12/12 h	150 mil UI/kg/dia 8/8 h	150 mil UI/kg/dia 8/8 h	200 mil UI/kg/dia 6/6 h
Cefotaxima	100–150 mg/kg/dia 12/12 h		200 mg/kg/dia 6/6 h	
Amicacina	15 mg/kg/dia 12/12 h	20 mg/kg/dia 12/12 h	30 mg/kg/dia 8/8 h	
Gentamicina	5 mg/kg/dia 12/12 h	7,5 mg/kg/dia 12/12 h	7,5 mg/kg/dia 8/8 h	

[MS-GVS], Quadro 2. A tabela não resolve o peso exatamente de 2.000 g nem traz tetos, ajuste renal ou níveis séricos.

Cai na prova · por que ampicilina + aminoglicosídeo

Pelo espectro de cada um e pelo **sinergismo** contra enterobactérias que também causam meningite nessa idade. A penicilina pode substituir a ampicilina [MS-GVS].

Atenção · Ministério × OMS no recém-nascido

O Guia divide a gentamicina em 12/12 ou 8/8 h; a OMS 2024 dá dose única diária (5 mg/kg na 1ª semana, 7,5 mg/kg depois) e duração de **pelo menos 3 semanas** na meningite. Na prova, a referência da questão; no plantão, o protocolo da neonatologia [MS-GVS] [OMS-24].

Conduta · com o resultado da cultura

Identificado o agente no líquor, pode-se passar a um só antibiótico, escolhido pelo antibiograma [MS-GVS].

Capítulo V

Quimioprofilaxia de contatos

*Para **doença meningocócica** e **doença invasiva por Hib**, o mais cedo possível, idealmente nas primeiras **24 h** após o início dos sintomas do caso. Após **10 dias** da exposição, o benefício no meningococo é limitado ou nulo; no Hib, pode ser feita até **30 dias** [MS-NT].*

Tabela 6 · *Esquemas (Nota Técnica 154/2024)*

	Meningococo	Hib
Rifampicina < 1 mês	5 mg/kg/dose 12/12 h, 2 dias	10 mg/kg/dose 1×/dia, 4 dias
Rifampicina ≥ 1 mês	**10 mg/kg/dose** (máx. 600 mg) **12/12 h, 2 dias**	**20 mg/kg/dose** (máx. 600 mg) **1×/dia, 4 dias** (até < 18 anos)
Ceftriaxona	< 12 anos 125 mg IM; ≥ 12 anos 250 mg IM; dose única	< 12 anos 50 mg/kg IM/IV 1×/dia, 2 dias
Ciprofloxacino	≥ 18 anos: 500 mg VO, dose única	—

[MS-NT]. Rifampicina é a primeira escolha; ceftriaxona e ciprofloxacino, se indisponível, contraindicada ou adesão incerta. Gestante: ceftriaxona. Lactante pode usar rifampicina.

Quem recebe · meningococo

- Contatos próximos do caso suspeito ou confirmado.
- O **próprio paciente**, se não foi tratado com ceftriaxona ou cefotaxima [MS-NT].

Quem recebe · Hib

- Todos do domicílio, se nele houver imunocomprometido, criança < 2 anos (vacinada ou não) ou < 4 anos com vacinação incompleta.
- O próprio paciente, se não tratado com ceftriaxona ou cefotaxima; o contato direto que tenha vulnerável em casa.
- Creche: cuidadores e crianças < 4 anos da sala, se há vulnerável; 2º caso em até 60 dias, toda a sala [MS-NT].

Cai na prova · os dois esquemas de rifampicina

Meningococo: 10 mg/kg 12/12 h por 2 dias. Hib: 20 mg/kg 1×/dia por 4 dias. Máximo de 600 mg por dose nos dois [MS-NT].

Atenção · contato próximo tem definição

Exposição direta e prolongada a secreções respiratórias, dos 10 dias antes dos sintomas até 24 h após o início de ceftriaxona, cefotaxima ou rifampicina no caso: moradores, quem dorme junto, beijo, ambiente fechado ≥ 4 h a até 1 m, manobra de via aérea sem EPI. Passar perto não conta [MS-NT].

Capítulo VI

Infecção urinária: diagnóstico

*Suspeitar de ITU no lactente com **febre sem foco por mais de 24 horas**. O diagnóstico depende de colher bem a urina* [SBP-ITU].

Como colher

- **Sem controle esfincteriano**: cateterismo vesical ou punção suprapúbica; o jato limpo (*clean catch*) também é aceito.
- **Com controle esfincteriano**: jato intermediário.
- **Saco coletor**: resultado positivo precisa ser confirmado por método invasivo; serve para afastar ITU só em quadro leve, em que esperar não prejudique [SBP-ITU].

Tabela 7 · *Urocultura positiva*

Coleta	Corte
Punção suprapúbica	Qualquer contagem
Cateterismo	> 1.000 UFC/mL
Jato intermediário	> 50 a 100 mil UFC/mL

[SBP-ITU]

Sedimento sugestivo

- > 5–10 leucócitos por campo de grande aumento
- Nitrito positivo
- Esterase leucocitária positiva
- Bactérias [SBP-ITU]

Cai na prova · saco coletor positivo não é ITU

Lactente febril com urocultura de saco coletor positiva: confirmar por cateterismo ou punção antes de rotular ITU [SBP-ITU].

Atenção · cultura positiva sozinha

ITU é processo inflamatório **sintomático** com germe patogênico; cultura positiva isolada pode ser contaminação ou colonização [SBP-ITU] [AWaRe].

Capítulo VII

Infecção urinária: tratamento e depois

Menor espectro possível, guiado pelo Gram ou pela sensibilidade local da E. coli (resistência < 20%). ***Via oral*** *preferencial acima de* ***3 meses****. ITU febril:* ***10 dias*** *[SBP-ITU].*

Tabela 8 · *Antibióticos na ITU (SBP 2021)*

Situação	Esquema
Febril, parenteral	Cefuroxima 150 mg/kg/dia 8/8 h · gentamicina 5–7,5 mg/kg/dia 1×/dia IV/IM · amicacina 15 mg/kg/dia 1×/dia · cefotaxima 150–200 mg/kg/dia 8/8 h
Febril, oral	**Cefuroxima 30 mg/kg/dia 12/12 h** · cefaclor 40 mg/kg/dia 8/8 h
Afebril, oral	Nitrofurantoína 5–7 mg/kg/dia 6/6 h · cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6 ou 8/8 h · SMX-TMP 8–12 mg de TMP/kg/dia 12/12 h

[SBP-ITU]. O quadro não traz doses máximas nem duração para a ITU afebril.

Cai na prova · nitrofurantoína não trata pielonefrite

Com febre, o rim precisa de nível adequado de antibiótico: **nitrofurantoína e ácido nalidíxico são contraindicados** na ITU febril [SBP-ITU].

Internar

- Idade < 2 meses
- Criticamente doente
- Risco de não aderir [SBP-ITU]

Reavaliar

Em 48–72 h, com antibiograma, pensando em descalonar. Sem melhora em 48 h: afastar anomalia urinária e ampliar. Com resposta e sensibilidade confirmada, sem cultura de controle [SBP-ITU].

Imagem

Ultrassom de rins e bexiga na pielonefrite abaixo de 2 anos; uretrocistografia e DMSA em casos selecionados. Não há protocolo único consensual [SBP-ITU].

Profilaxia

Individualizada, até concluir a investigação: US alterado, RVU IV–V, uropatia obstrutiva, ITU recorrente (≥ 2 pielonefrites, 1 cistite + 1 pielonefrite ou ≥ 3 cistites). Nitrofurantoína ou SMX-TMP em ⅓ a ½ da dose terapêutica, 1×/dia, à noite [SBP-ITU].

Capítulo VIII

Vias aéreas em uma página

Resumo das escolhas já detalhadas nos cadernos de IVAS e Pneumonia. A maioria das IVAS é viral: o primeiro passo é decidir se há infecção bacteriana [ABORL] [SBP-PAC].

Tabela 9 · *Primeira escolha e alternativas*

Quadro	Primeira escolha	Alternativa ou falha
OMA (AIDPI)	Amoxicilina **50 mg/kg/dia** 8/8 h (BD 12/12 h), **8 dias**; retorno em 2 dias	Falha: amoxicilina 80 mg/kg/dia 12/12 h ou amox-clav. Alergia não imediata: cefuroxima 30; imediata: claritromicina 15 mg/kg/dia
Faringite estreptocócica	Amoxicilina **50 mg/kg/dia** 8/8 h, **10 dias**; ou benzatina IM dose única: < 20 kg 600.000 UI, ≥ 20 kg 1.200.000 UI	Alergia: claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12 h (máx. 250 mg/dose) ou eritromicina 40 mg/kg/dia, 10 dias
Sinusite bacteriana	Amoxicilina **25–50 mg/kg/dia** 8/8 ou 12/12 h, **7–10 dias**	90 mg/kg/dia se suspeita de pneumococo resistente
PAC ambulatorial	Amoxicilina **50 mg/kg/dia** 8/8 ou 12/12 h, máx. 4 g/dia, **7 dias**	Atípico: azitromicina 10 mg/kg/dia, 5 dias
PAC internada	Ampicilina **50 mg/kg/dose IV 6/6 h** ou penicilina cristalina 150.000 UI/kg/dia 6/6 h	Complicada: ver caderno de Pneumonia

[AIDPI] [ABORL] [SBP-PAC]. A benzatina pela ABORL usa o corte de 27 kg.

Cai na prova · antibiótico que não precisa

Resfriado, crupe viral típico, bronquiolite e efusão residual depois da OMA **não** pedem antibiótico; e ASLO não diagnostica faringite aguda [ABORL].

Atenção · a dose de OMA depende da fonte

AIDPI usa 50 mg/kg/dia; a AAP usa 80–90 mg/kg/dia; a ABORL não considera a dose alta necessária como regra no Brasil. Nomeie a referência [AIDPI] [ABORL].

Capítulo IX

Pele e disenteria

Impetigo e celulite leve

Tabela 10 · *Infecção de pele leve (AWaRe)*

Impetigo localizado	Mupirocina 2% tópica, curso curto de 5 dias
Extenso ou celulite leve	**Cefalexina 25 mg/kg/dose VO 12/12 h** (≥ 30 kg: dose adulta, 500 mg 8/8 h) ou cloxacilina 15 mg/kg/dose VO 6/6 h; cerca de 5 dias, conforme resposta
Alternativa mais ampla	Amoxicilina-clavulanato 80–90 mg/kg/dia (de amoxicilina)

[AWaRe]. Cefalexina e cloxacilina têm espectro mais estreito e são preferidas.

Abscesso pode precisar de **drenagem**; antibiótico sozinho não resolve. Não colher swab de pele íntegra; ultrassom se houver dúvida de coleção [AWaRe].

Diarreia com sangue

Antibiótico na disenteria com comprometimento do estado geral e na cólera grave; diarreia aquosa comum não leva antibiótico. A reidratação continua sendo o centro [MS-DIA].

Tabela 11 · *Disenteria (cartaz MS 2026)*

≤ 30 kg, ≥ 3 meses	**Azitromicina 10 mg/kg no 1º dia + 5 mg/kg/dia do 2º ao 5º**; alternativa: ceftriaxona 50 mg/kg IM 1×/dia, 3–5 dias
< 3 meses ou imunodeficiente	Ceftriaxona 50–100 mg/kg IV 1×/dia; fora do hospital, 1ª dose IM e referência
> 30 kg	Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 h, 3 dias

[MS-DIA]. Reavaliar em 2 dias; sangue persistente após 48 h de tratamento: até 10 anos, internação.

Cai na prova · o cartaz mudou

O ciprofloxacino deixou de ser a escolha universal da criança: até 30 kg, **azitromicina** [MS-DIA].

Capítulo X

Recém-nascido e lactente pequeno

Até 59 dias de vida a apresentação é inespecífica (recusa alimentar, letargia, irritabilidade, convulsão, fontanela abaulada; rigidez de nuca é incomum) e a criança doente grave precisa de referência [OMS-24] [AWaRe].

Tabela 12 · *Atualização OMS 2024, tratamento hospitalar*

Suspeita	1ª semana de vida	Depois da 1ª semana	Duração
Sepse	Ampicilina 50 mg/kg 12/12 h + gentamicina 5 mg/kg 1×/dia	Ampicilina 50 mg/kg 8/8 h + gentamicina 7,5 mg/kg 1×/dia	≥ 10 dias (antes 7)
Sepse estafilocócica	Cloxacilina 50 mg/kg 12/12 h + gentamicina 5 mg/kg 1×/dia	Cloxacilina 50 mg/kg 8/8 h + gentamicina 7,5 mg/kg 1×/dia	≥ 10 dias
Meningite	(Ampicilina 50 mg/kg 12/12 h ou cefotaxima 50 mg/kg 12/12 h) + gentamicina 5 mg/kg 1×/dia	(Ampicilina 50 mg/kg 8/8 h ou cefotaxima 50 mg/kg 6/6 h) + gentamicina 7,5 mg/kg 1×/dia	≥ 3 semanas

[OMS-24]. IM ou IV; doses por tomada.

Atenção · ceftriaxona no recém-nascido

Evitar no período neonatal (compete com a bilirrubina) e nunca junto com cálcio IV; o AWaRe a restringe a neonatos com idade gestacional corrigida acima de 41 semanas. Preferir **cefotaxima** [MS-GVS] [AWaRe].

Conduta · sepse neonatal precoce (manual MS)

Precoce: nas primeiras 48 h. Empírico: **ampicilina 200 mg/kg/dia + gentamicina 5 mg/kg/dia** (amicacina 20 mg/kg/dia se a resistência da unidade pedir). Com forte suspeita, não aguardar resultado; se não puder puncionar o líquor, usar dose de meningite [MS-RN].

Cai na prova · suspeita afastada não é infecção tratada

A duração de 10 dias da OMS é para infecção tratada; não é curso obrigatório de toda investigação. O manual de 2014 é anterior e não tem intervalos nem ajuste por prematuridade [OMS-24] [MS-RN].

Capítulo XI

Mapa de decisão e pegadinhas

Precisa?	Foco bacteriano provável ou criança grave? Viral típico: sem antibiótico.
Quanto tempo	Choque: até 1 h. Sepse provável: até 3 h. Meningite: não esperar líquor nem TC.
Culturas	Hemocultura, urina bem colhida, líquor se possível, sem atrasar a dose.
Qual	Pela síndrome, idade (< 2 meses tem esquema próprio), alergia verdadeira e resistência local.
Quanto	mg/kg/dia ou /dose? Componente certo? Concentração da suspensão? Teto?
Revisar	48–72 h com cultura: estreitar, trocar para VO, definir a data de término.

Tabela 13 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Ceftriaxona para o recém-nascido com meningite	Cefotaxima + ampicilina
Vancomicina isolada no pneumococo resistente	Sempre com cefalosporina de 3ª geração
Rifampicina do Hib igual à do meningococo	Hib 20 mg/kg 1×/dia, 4 dias; meningococo 10 mg/kg 12/12 h, 2 dias
Paciente tratado com ceftriaxona precisa de profilaxia	Não, nem com cefotaxima; só se tratado com outra droga
Nitrofurantoína na pielonefrite	Contraindicada na ITU febril
Saco coletor positivo confirma ITU	Confirmar por cateterismo ou punção
Ciprofloxacino na disenteria de criança de 15 kg	Azitromicina
Celulite com amoxicilina simples	Cefalexina ou cloxacilina
"Alergia" por diarreia com amoxicilina	Efeito adverso, não alergia

Capítulo XII

Questões de estudo

1. Criança de 3 anos com meningite bacteriana, agente ainda desconhecido. Pelo Ministério da Saúde, o esquema empírico é:

A Ampicilina + gentamicina.
B Ceftriaxona 100 mg/kg/dia de 12/12 h.
C Vancomicina isolada.
D Amoxicilina VO.

2. Recém-nascido de 5 dias, 3.200 g, com meningite. A associação recomendada pelo Guia é:

A Ceftriaxona isolada.
B Ampicilina + cefotaxima.
C Vancomicina + ceftriaxona.
D Cloranfenicol.

3. Irmão de 6 anos (22 kg) de um caso de doença meningocócica. A profilaxia é:

A Rifampicina 220 mg 12/12 h por 2 dias.
B Rifampicina 440 mg 1×/dia por 4 dias.
C Ciprofloxacino 500 mg.
D Nenhuma.

4. Lactente de 8 meses, febre há 3 dias sem foco, urocultura por saco coletor com 100 mil UFC/mL. A conduta é:

A Tratar como ITU.
B Colher por cateterismo e reavaliar.
C Repetir com saco coletor em 7 dias.
D Dar nitrofurantoína.

5. Menina de 2 anos com pielonefrite, bom estado, aceita VO. Pela SBP:

A Nitrofurantoína 5–7 mg/kg/dia, 5 dias.
B Cefuroxima 30 mg/kg/dia 12/12 h, 10 dias.
C Internar para ceftriaxona.
D Amoxicilina 3 dias.

6. Criança de 4 anos (16 kg), disenteria com comprometimento do estado geral. Pelo cartaz do MS:

A Ciprofloxacino 500 mg 12/12 h.
B Azitromicina 160 mg no 1º dia e 80 mg/dia por mais 4 dias.
C Metronidazol.
D Sem antibiótico.

Gabarito comentado

1 · B. Acima de 2 meses: cefalosporina de 3ª geração; ceftriaxona 100 mg/kg/dia de 12/12 h [MS-GVS].

2 · B. Abaixo de 2 meses: ampicilina + cefotaxima; evitar ceftriaxona no neonato [MS-GVS].

3 · A. Meningococo, ≥ 1 mês: 10 mg/kg/dose (22 kg = 220 mg) 12/12 h por 2 dias. A alternativa b é o esquema do Hib [MS-NT].

4 · B. Saco coletor positivo precisa de confirmação por método invasivo [SBP-ITU].

5 · B. ITU febril, > 3 meses, bom estado: via oral, 10 dias; nitrofurantoína é contraindicada com febre [SBP-ITU].

6 · B. ≤ 30 kg: azitromicina 10 mg/kg no 1º dia (160 mg) e 5 mg/kg/dia (80 mg) do 2º ao 5º [MS-DIA].

Apêndice

Fontes e anotações

- [MS-GVS] BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia de Vigilância em Saúde*. 6. ed., v. 1. Brasília, 2024. Doença meningocócica e outras meningites.
- [MS-NT] BRASIL. Ministério da Saúde. *Nota Técnica Conjunta nº 154/2024*: definições e quimioprofilaxia das meningites.
- [SBP-ITU] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. DC de Nefrologia. *Infecção do trato urinário em pediatria: existe consenso entre os consensos?* Atualização 2021.
- [AWaRe] WORLD HEALTH ORGANIZATION. *The WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) antibiotic book*. Geneva, 2022.
- [OMS-24] WHO. Diferenças entre o livro AWaRe e as diretrizes OMS 2024 para crianças (infecção grave do lactente pequeno, pneumonia, diarreia).
- [MS-RN] BRASIL. Ministério da Saúde. *Atenção à saúde do recém-nascido*, v. 2. 2. ed. 2014.
- [SSC] Surviving Sepsis Campaign: diretrizes pediátricas 2026. [PHX] SBP: critérios de Phoenix, 2024.
- [MS-DIA] BRASIL. MS/SVSA. *Manejo do paciente com diarreia* (cartaz, 2026). [AIDPI] MS/OPAS, AIDPI Criança, 2017.
- [ABORL] ABORL-CCF: antibióticos nas IVAS e rinossinusites 2024. [SBP-PAC] SBP: PAC não complicada (2022) e complicada (2024).